

• **Status pulmonaire** :

→ Mettre le patient torse-nu :

A) Observation :

- 1) Forme, cyanose, cicatrices.
- 2) Fréquence respiratoire.
- 3) **Tirages**.
- 4) Amplitude.
- 5) Thorax en tonneau / en carène.

B) Palpation :

→ Se positionner derrière le patient

- Amplitude resp.
- Frémitus : = test du 33.
- **Ganglions** : pré-auriculaire, post-auriculaire, chaîne cervicale, sus-claviculaire & chaîne pré-SCM.

C) Percussion : ant & post.

D) Auscultation :

- 1) **Pulmonaire** : minimum 2 points à chaque fois → ant. post. **et latéral**.
- 2) **Trachée** : insp. & exp. max.

• **Status CV** :

→ Mettre le patient torse-nu, evt. retirer pantalon pour voir œdèmes.

A) Observation : forme, cyanose, cicatrices.

B) Palpation :

- 1) **Pouls** : ← tjrs bilatéral !
 - Radial (fréq. resp. & cardiaque)
 - Brachial (sous le biceps).
 - Carotidien & jugulaire (?)
 - Poplitée.
 - Malléolaire int.
 - Pédieuse.
- 2) Rythme cardiaque & respiratoire (pris en // avec le pouls)
- 3) **Œdèmes** : profiter d'être en bas pour essayer un signe du godet.
- 4) Choc de pointe.
- 5) 2 EIC, à la recherche d'un frémitus.

C) Auscultation :

- 1) Foyers cardiaques.
- 2) Carotides.
- 3) Aisselles.